Impacto del tratamiento con bimekizumab en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con psoriasis: datos preliminares a 6 meses.

María del Mar Llamas Velasco[1], Esther Ramírez Herraiz[2], Gabriel Mercadal Orfila[3], Vicenç Rocamora Durán[4], ……. Salvador Herrera Pérez[23]

[1]Dermatología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, [2]Servicio Farmacia. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, [3]Servicio de Farmacia. Hospital Mateu Orfila, Maó (Illes Balears) - España, [4]Servicio Dermatología. Hospital de Manacor, Manacor (Illes Balears) - España,[23]Profesor Facultad Ciencias de la Salud - VIU. Universidad Internacional de Valencia (VIU), Valencia - España.

Contexto y objetivos

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que impacta negativamente en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), afectando tanto el bienestar físico como emocional de los pacientes. Bimekizumab, un anticuerpo monoclonal que inhibe simultáneamente las interleucinas IL-17A e IL-17F, ha sido aprobado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave. Los estudios pivotales han demostrado que este fármaco no solo mejora de forma significativa los indicadores clínicos de actividad de la enfermedad, sino que también se asocia con beneficios sustanciales en la CVRS de los pacientes. Este estudio tiene como objetivo evaluar la evolución longitudinal de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con psoriasis tratados con Bimekizumab durante un periodo de seguimiento de 12 meses en condiciones de práctica clínica real.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio prospectivo, multicéntrico y observacional en pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave tratados con Bimekizumab en condiciones de práctica clínica habitual. Los pacientes fueron monitorizados a través de la plataforma de telemedicina NAVETA, con puntos de recogida de datos en las semanas basal, 4, 16, 24 y 52. La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se evaluó mediante los cuestionarios: Psoriasis Symptoms and Signs Diary (PSSD - 7 días), Dermatology Life Quality Index (DLQI) y Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). En esta fase del análisis, se presentan los resultados preliminares correspondientes al seguimiento hasta la semana 24.

Resultados

Distribución de Pacientes

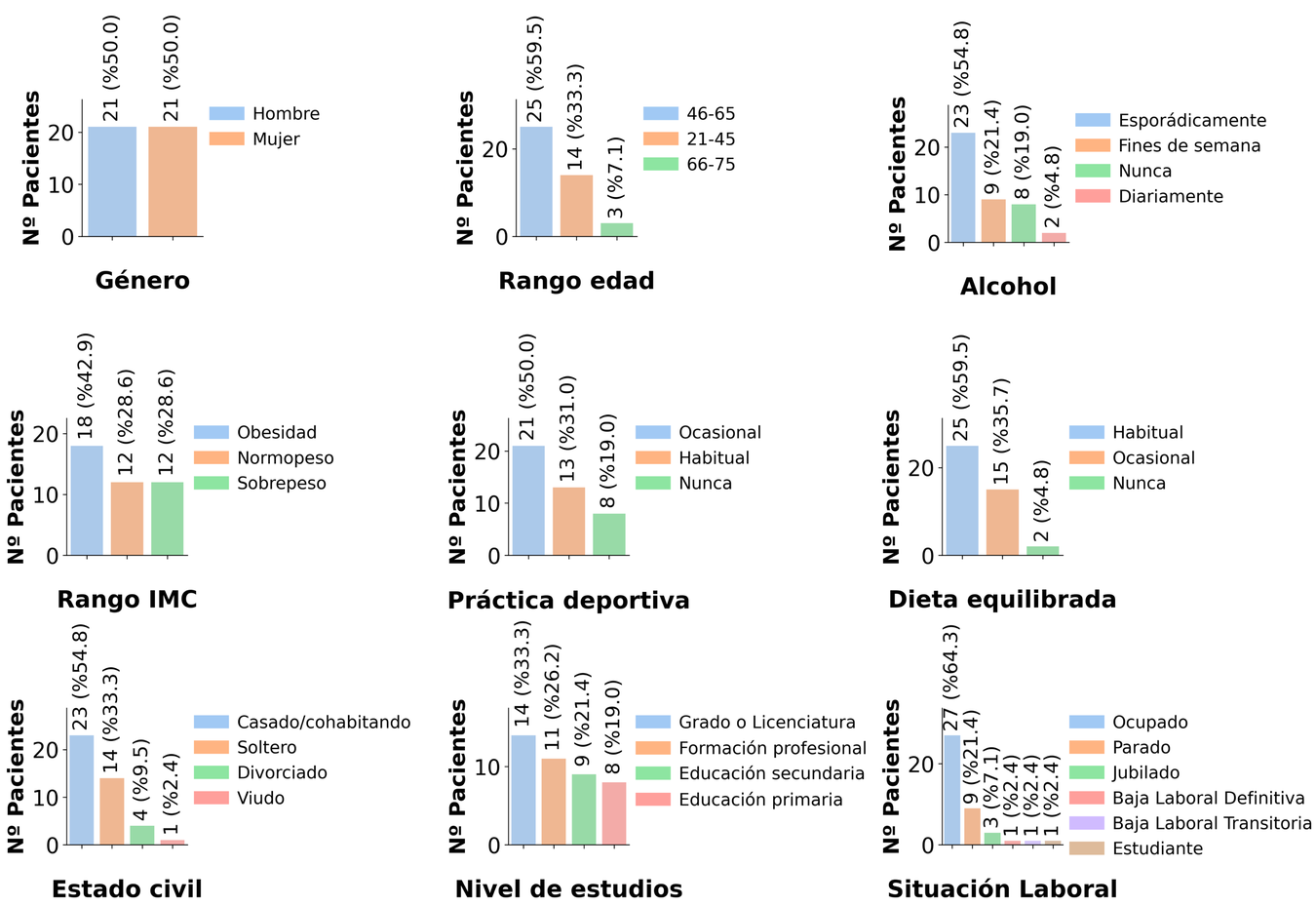

Figura 1. Distribución de pacientes según variables sociodemográficas y de estilo de vida.
La cohorte analizada presenta una distribución equitativa por género, con un 50% de hombres y un 50% de mujeres. En cuanto al rango de edad, el grupo predominante es el de 46–65 años (59,5%), seguido del de 21–45 años (33,3%) y el de 66–75 años (7,1%). En relación con el índice de masa corporal (IMC), el 42,9% de los pacientes presenta obesidad, el 28,6% normopeso y el 28,6% sobrepeso. Respecto a la práctica deportiva, el 50% realiza ejercicio de forma ocasional, el 31% de forma habitual y el 19% nunca. En cuanto a los hábitos alimentarios, el 59,5% de los pacientes sigue una dieta equilibrada de forma habitual, el 35,7% de forma ocasional y el 4,8% nunca. Sobre el consumo de alcohol, un 54,8% lo hace de forma esporádica, un 21,4% los fines de semana, un 19% nunca y un 4,8% diariamente. En términos de estado civil, el 54,8% está casado o en convivencia, el 33,3% es soltero, el 9,5% divorciado y el 2,4% viudo.

Evolución de la CVRS a lo largo del seguimiento (6 meses)

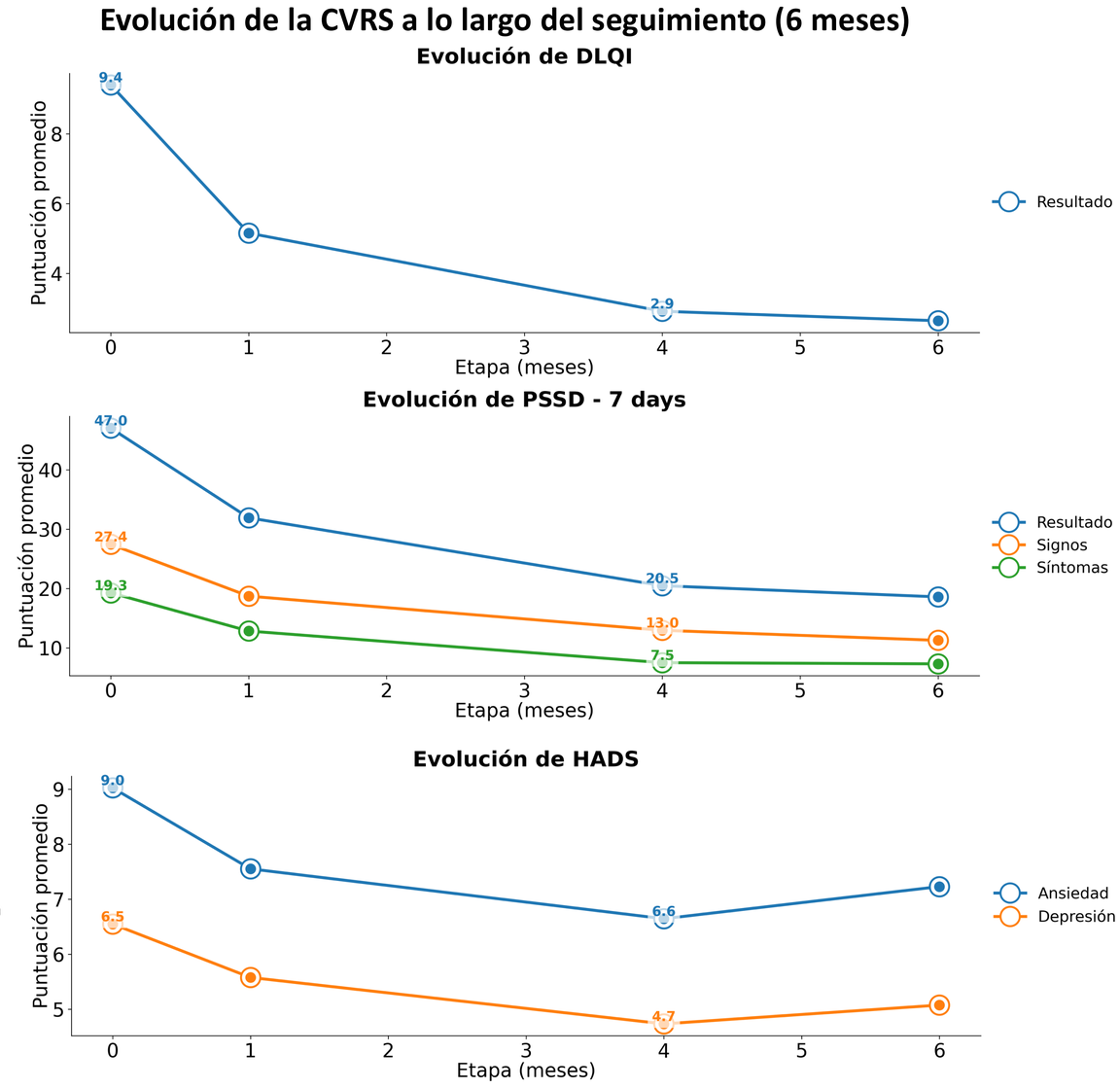

Figura 2. Evolución en CVRS. Los resultados del cuestionario DLQI mostraron una mejora significativa ($p < 0.05$) en la CVRS, con una disminución de la puntuación de 9.19 ± 7.99 en la visita basal a 2.87 ± 3.91 a los 6 meses. En el cuestionario PSSD - 7 days, los resultados mostraron una mejora significativa ($p < 0.05$), con una disminución de la puntuación de 47.16 ± 27.62 en la visita basal a 20.80 ± 22.05 a los 6 meses Respecto al HADS, si bien se observó una tendencia a la disminución de los valores de depresión y ansiedad a lo largo del seguimiento, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes momentos de valoración.

Evolución de la CVRS a lo largo del seguimiento (6 meses) por sexos

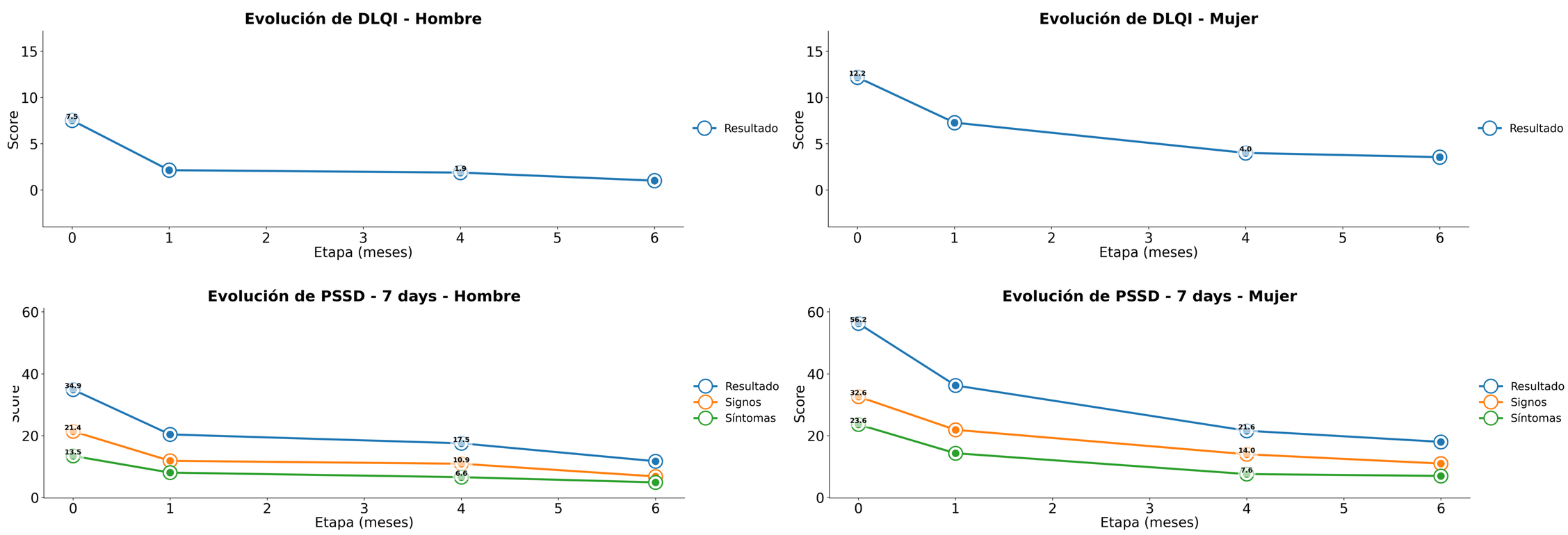

Figura 3. Evolución en CVRS segregada por sexos. La evolución de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), medida mediante los cuestionarios PSSD (síntomas, signos y resultado total) y DLQI, mostró una mejoría progresiva en ambos sexos durante los primeros 6 meses de tratamiento con Bimekizumab. En la etapa basal, las mujeres presentaron puntuaciones más elevadas que los hombres en todos los dominios del PSSD y en el DLQI, reflejando una mayor carga percibida de enfermedad al inicio (PSSD total: 56,3 vs. 34,9; DLQI: 12,2 vs. 7,5). Estas diferencias iniciales fueron estadísticamente significativas ($p < 0,05$) o mostraron tendencias claras, especialmente en los dominios de síntomas ($p = 0,015$) y en el DLQI basal ($p = 0,051$).

Agradecimientos

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los pacientes que amablemente han permitido la inclusión de sus datos anónimos, así como a los profesionales sanitarios que han contribuido al proyecto.

Conclusiones

A los 6 meses, los pacientes tratados con Bimekizumab mostraron una mejora significativa en la CVRS, evaluada con los cuestionarios DLQI y PSSD - 7 days. Estos resultados respaldan el impacto positivo sostenido de Bimekizumab sobre la calidad de vida de los pacientes con psoriasis.

52 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología
VALENCIA 7/10 MAYO
AEDV 2025

ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA